



СЕМИНАР «ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ИДЕЙ 2.0» · МИНТРУД РОССИИ · СПБ, 25–27.08.2026

Цена заботы

Стоимость социального обслуживания и психиатрической помощи лицам с психическими заболеваниями: регионы России и 47 стран мира

Доклад третий · 150 страниц · 48 стран · 20 графиков · 60+ таблиц

Источники: Всемирный банк · ВОЗ Atlas 2011–2024 · ОЭСР · SAMHSA · NHS · Росстат



Пять чисел, которые всё объясняют

\$2,69

мировая медиана расходов на психическое здоровье на человека в год (ВОЗ, 2024)

1 : 4

окупаемость инвестиций в лечение депрессии и тревоги (Lancet Psychiatry, 2016)

2%

медианная доля бюджетов здравоохранения — не меняется с 2017 года

1 600 ₽

цена суток психиатрического проживания в России (РКПБ, Татарстан)

1 625×

разрыв расходов между богатыми (\$65) и бедными (\$0,04) странами

Как устроен разговор

- **I. Методология** — три измерения: цена, объём, качество; рубли и доллары
- **II. Мировая панорама** — миллиард человек, \$2,5 трлн и два процента
- **III–IV. Развитые страны** — 24 профиля: от \$13 473 (США) до греческих \$1 963
- **V. Развивающийся мир** — 23 профиля: помощь по цене чашки кофе
- **VI. Россия** — 147 больниц, 122 537 коек, 12 297 психиатров
- **VII. Регионы РФ** — от московских 3,8 до чукотских 48+ на 100 тыс.
- **VIII–IX. Сравнение и выводы** — сводные таблицы, чек-лист, квиз

Три измерения — без них сравнение бессмысленно

Цена

\$/чел. в год · доля бюджета · цена койко-дня · стоимость года пациента

Объём

койки · психиатры · госпитализации · охват лечением

Качество

принудительность · длительность · общинность · суицидальная смертность

Сравнивать системы только по деньгам — как сравнивать рестораны по цене меню, не пробуя еду.

Рубли для России, доллары для мира

Период	₽ за \$	Основание
2023 (основной массив данных)	85,25	Банк России
2024	92,57	Банк России
2025	≈83,6	Банк России
Июль–август 2026	≈79,5	текущий курс

Правило: **сравниваем цены — номинал; сравниваем возможности — добавляем ППС**. Курсы остальных 47 валют — из Всемирного банка (PA.NUS.FCRF), в паспорте каждой страны.

\$2,69

на человека в год — мировая медиана

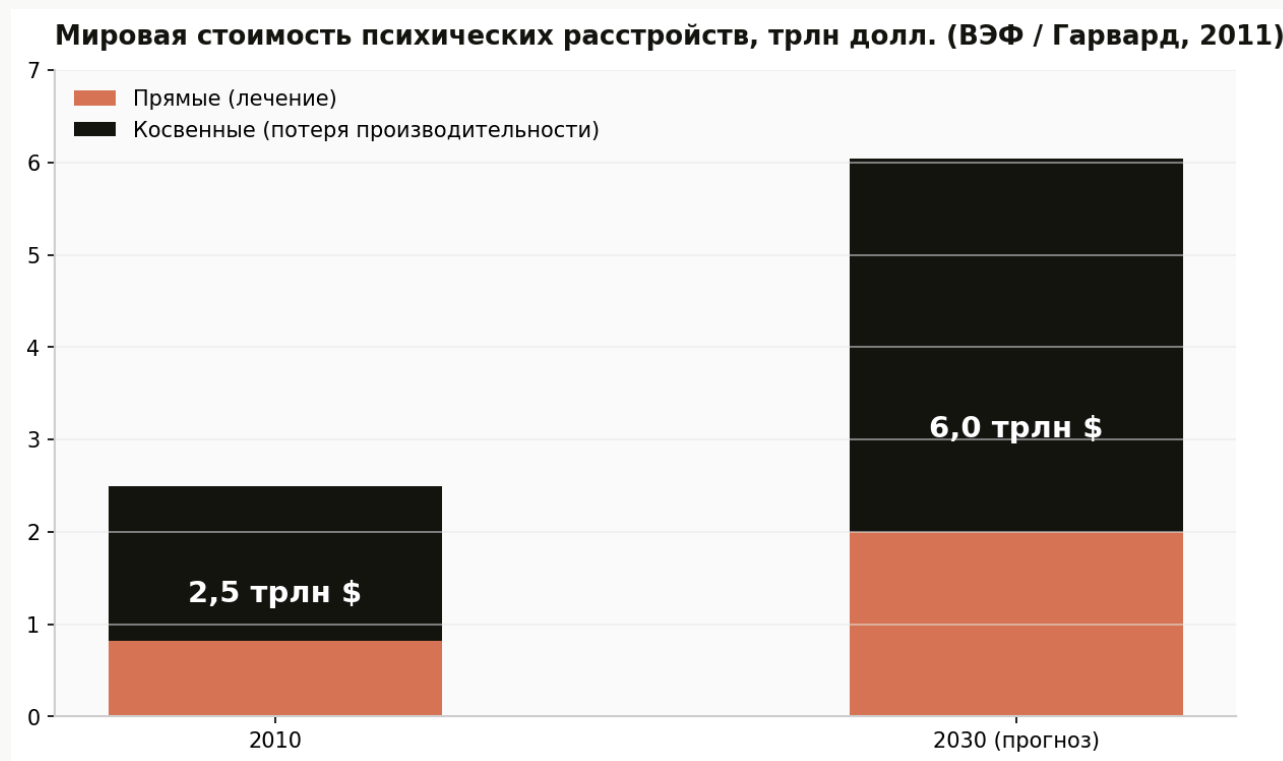
Меньше цены чашки кофе. Весь доклад — развёрнутый ответ на вопрос: кто, как и почему платит больше или меньше этой суммы.

1 млрд

человек с психическими расстройствами — каждый восьмой житель Земли

Депрессия и тревога одни только стоят мировой экономике \$1 трлн потерянной производительности в год.

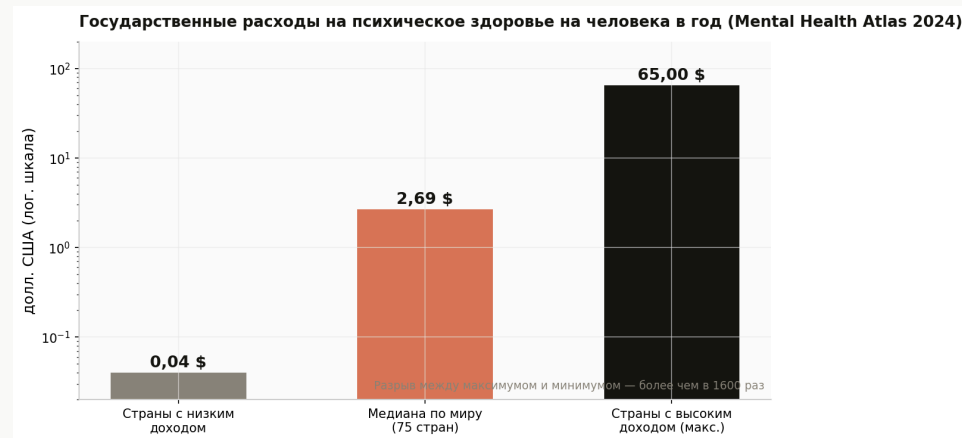
\$2,5 трлн → \$6,0 трлн за 20 лет



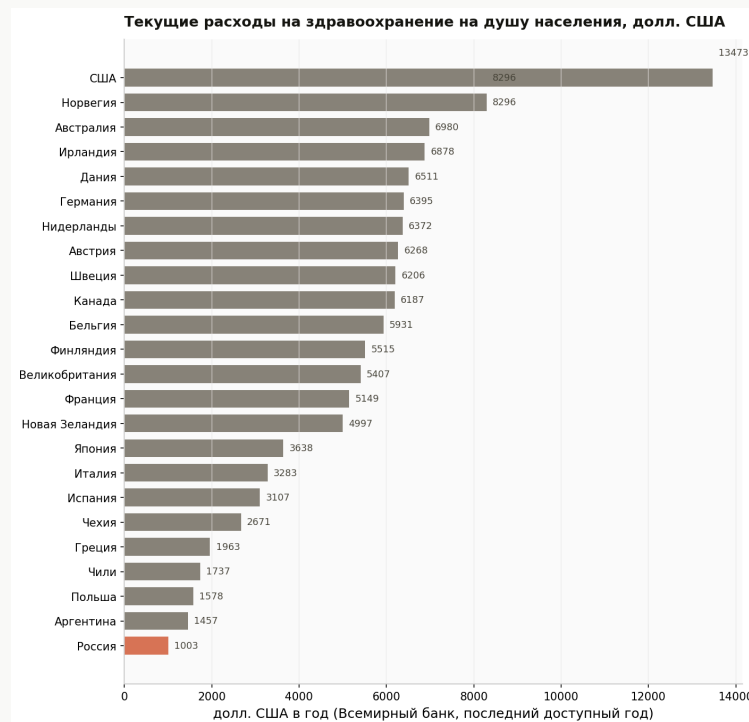
Два процента — и ни центом больше

Медианная доля бюджетов здравоохранения на психическое здоровье — **2%**, без изменений с 2017 года. Абсолютные значения: от **\$0,04** (бедные страны) до **\$65** (богатые) на человека в год.

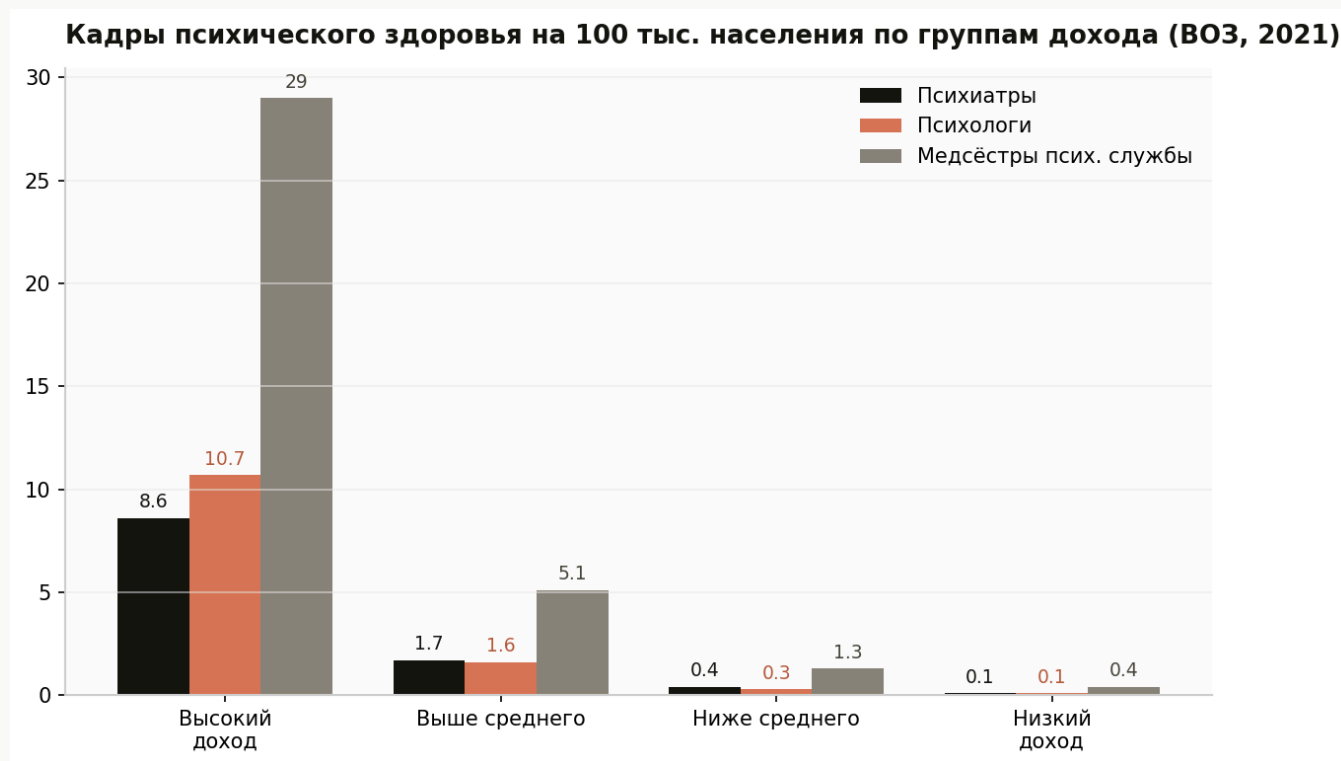
В Англии на психические расстройства — **более 20% бремени болезней** при **менее 9% расходов NHS**. Такой перекоc — мировая норма, а не исключение.



Расходы на здравоохранение: от \$30 до \$13 473



86 психиатров против одного



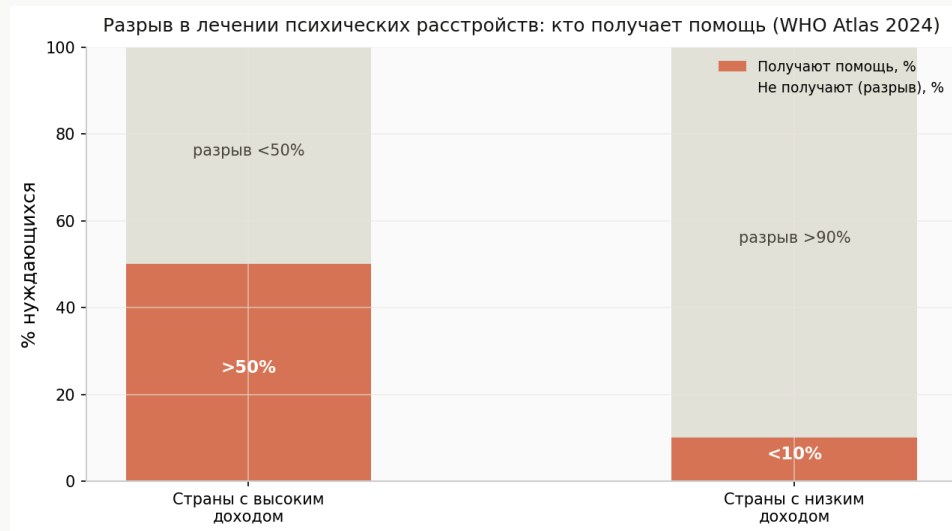
32-кратный разброс внутри ОЭСР



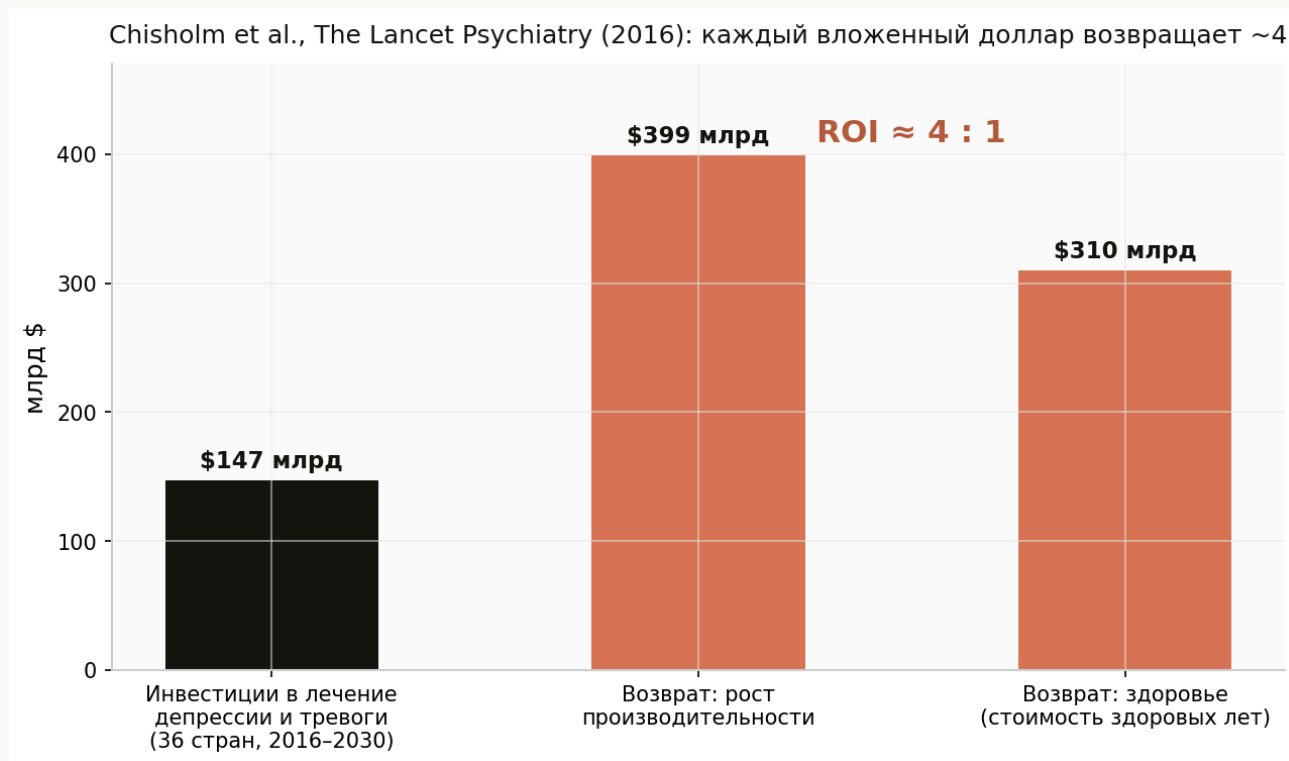
Разрыв в лечении

В бедных странах минимально адекватную помощь получают **менее 10%** нуждающихся, в богатых — **более 50%**. Охват психозов в мире — 29%, депрессии — 40%.

Индия: разрыв 70–92% — худшие надёжно измеренные значения среди крупных стран.



Доллар возвращает четыре



Что ВОЗ считает маркерами системы

~50%

госпитализаций в мире —
недобровольные

>20%

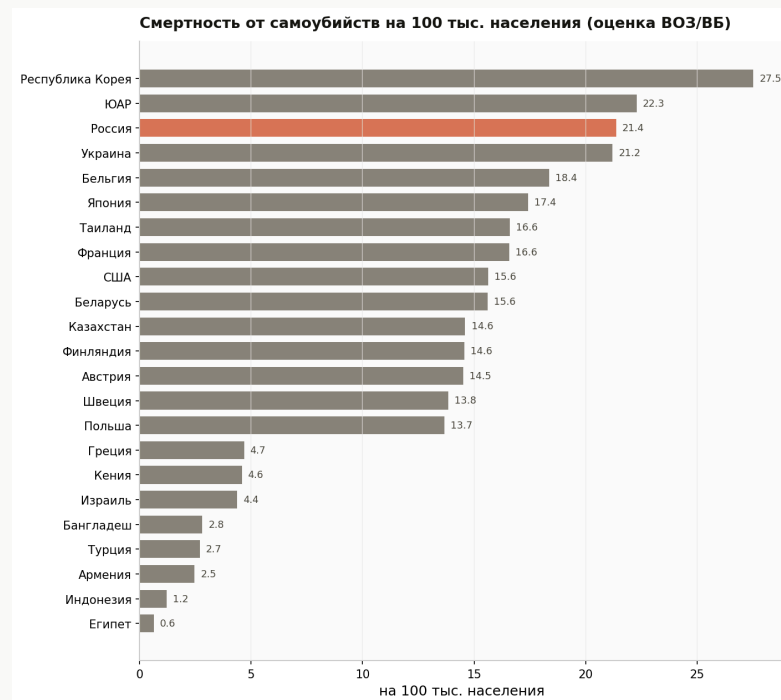
госпитализаций длится дольше года —
это уже институционализация

<10%

стран полностью перешли на общинную
модель

При этом 71% стран выполняют ≥ 3 из 5 критериев психиатрии в первичном звене — самый дешёвый и массовый шаг уже делается.

727 тысяч смертей от суицида в 2021 году



Цена высоких стандартов: 24 профиля

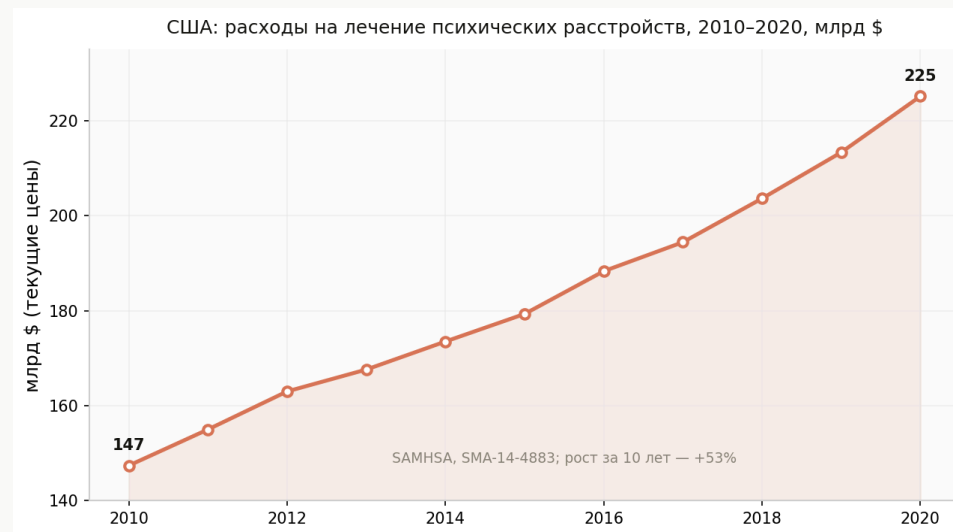
Страна	Здравоохран., \$/чел.	Суициды/100 тыс.	Фишка профиля
США	13 473	15,6	\$238 млрд на психиатрию, платит Medicaid
Великобритания	5 407	9,6	доля псих. здоровья — публичный KPI: 8,4–9,0%
Франция	5 149	16,6	рекордные ~14% расходов; €2 800 на пациента
Япония	3 638	17,4	2,58 коек/1 000; ALOS 500 → 266 дней
Германия	6 395	12,9	€10 493 — год пациента с тяжёлым расстройством
Италия	3 283	7,0	0,08 коек/1 000: больницы закрыты с 1978 г.
Корея	3 044	27,5	больше всех коек ОЭСР — и худший суицид

Самая дорогая психиатрия мира: \$238,4 млрд (2020)

+53% за 11 лет. 6,5% всех расходов на здравоохранение.

Крупнейший платательщик — **государственный Medicaid** (26–30%): даже в самой рыночной системе психиатрию оплачивает государство.

Коек при этом меньше медианы ОЭСР (0,35/1 000): деинституционализация перенесла нагрузку в тюрьмы и службы бездомных — «трансинституционализация».

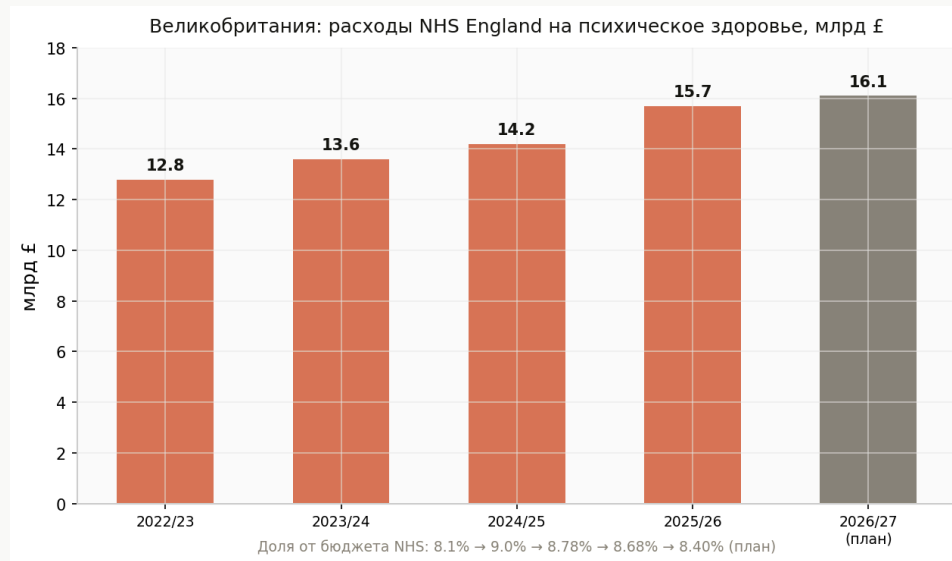


Паритет как KPI: £12,8 → £16,1 млрд

NHS England публикует долю психического здоровья в бюджете ежегодно: 8,1% → 9,0% → 8,4% (план 2026/27).

Широкий контур ICB (псих. здоровье + ЛД + деменция): £20,6 млрд, 14,2%.

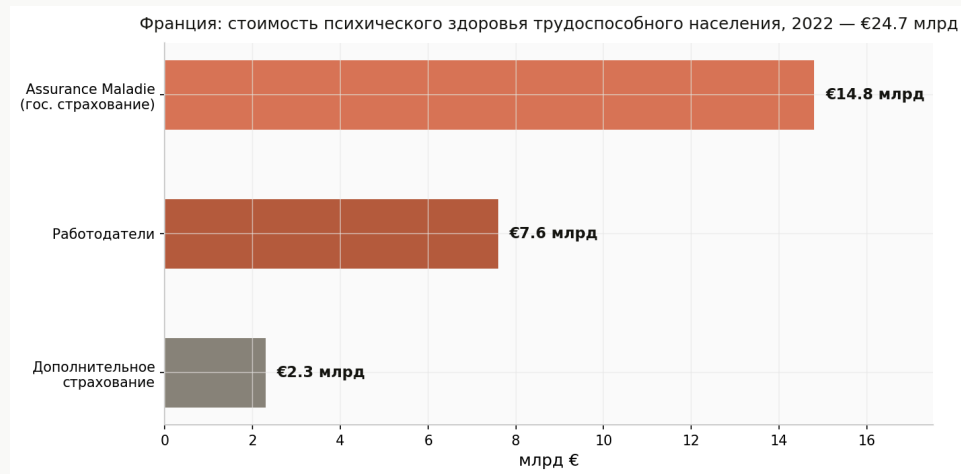
Цена вопроса для страны: ~£300 млрд в год; 1,8 млн человек ждут помощи.



~14% расходов — рекорд крупных стран

€23,3 млрд (2020) · €2 800 на пациента · ALD €27,8 млрд = 13,7% (2023).

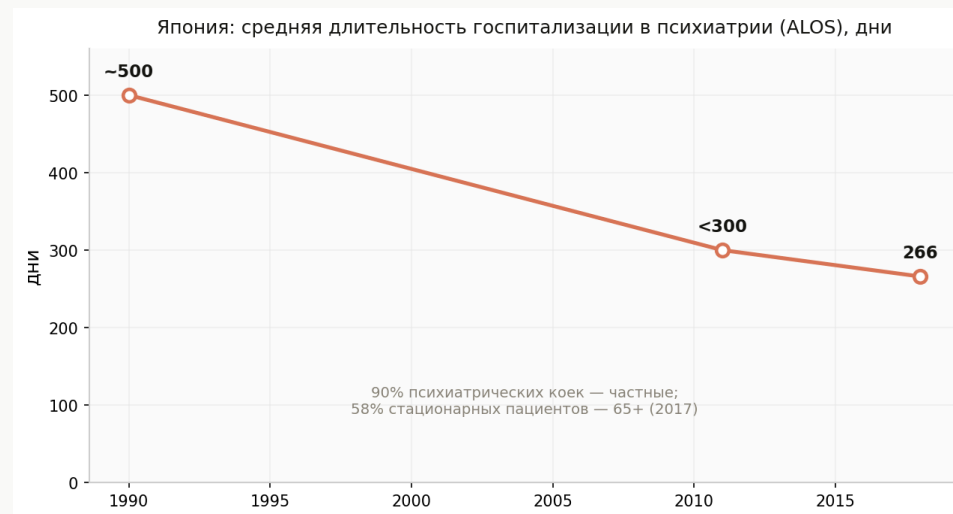
Стоимость для трудоспособного населения €24,7 млрд: **почти треть платят работодатели** — аргумент для вовлечения бизнеса в профилактику.



Как тарифом выдавить больницу из соцсферы

2,58 психиатрических коек на 1 000 — максимум мира; 90% коек частные; 58% пациентов — 65+.

ALOS: 500 дней (1990) → 266 (2018) — тридцать лет тарифной политики, выталкивающей длинные пребывания в сопровождаемое жильё.



€10 493

год жизни пациента с тяжёлым расстройством

Максимум пятистранного исследования 2022 года. В счёт входят лечение, реабилитация, сопровождаемое жильё и пенсионное обеспечение — полный контур, а не только койка.

| 45 лет без психиатрических больниц

0,08 коек на 1 000

Закон 180/1978 («закон Базалья») закрыл государственные психиатрические больницы, заменив их общинными центрами, дневными стационарами и койками при общих больницах.

Условие работоспособности — плотная финансируемая общинная сеть. Переносить «итальянский ноль» без неё — повторить американскую трансинституционализацию. Суициды: 7,0 на 100 тыс. — одни из самых низких в Европе.

Больше ресурсов ≠ лучше результат

12,6

коек всех профилей на 1 000 — максимум ОЭСР

27,5

суицидов на 100 тыс. — максимум выборки, вдвое выше США

Самая госпиталоцентричная система развитого мира соседствует с худшей суицидальной статистикой. Ответ страны — кризисные центры и горячие линии: от «больше коек» к «раньше помощь».

Дорогая забота и её альтернативная легализация

- **Норвегия \$8 296, Швеция \$6 206, Дания \$6 511, Финляндия \$5 515** на человека — самая дорогая социальная модель мира; суициды 10,5–14,6 — около или выше мировой медианы: деньги не снимают проблему.
- **Израиль: €6 955** — год пациента с тяжёлым расстройством; реабилитационная корзина (жильё, занятость, образование) легализована отдельным законом 2000 года и финансируется отдельно от лечения.
- **Израильские 4,4 суицида на 100 тыс.** — одно из низших значений выборки при высоком фоновом стрессе.

Израильская двухконтурная модель «лечение + легализованная реабилитация» — ближайший аналог связки Минздрав + Минтруд.

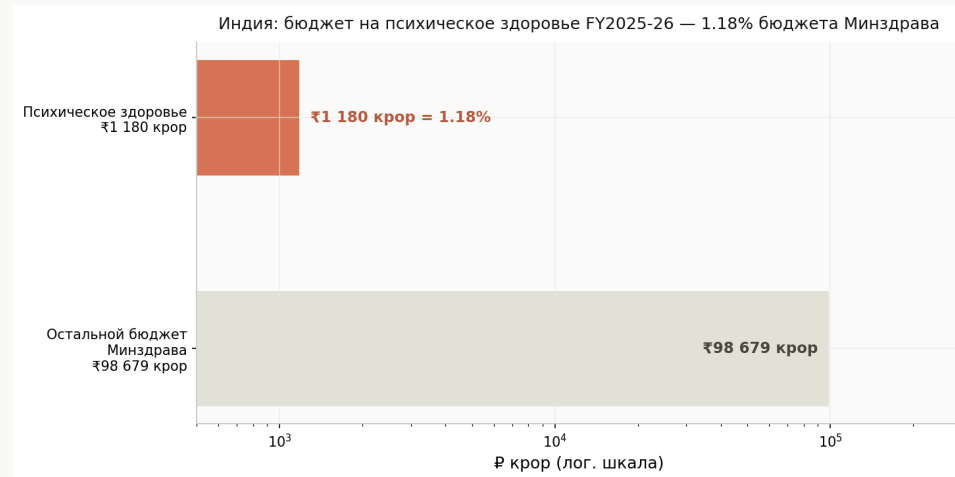
Помощь по цене чашки кофе: 23 профиля

Страна	Здравоохран., \$/чел.	2% (модель), \$/чел.	Фишка профиля
Бразилия	1 010	20,2	койки –58%, CAPS + пособие «Возвращение домой»
Казахстан	490	9,8	46,7% повторных госпитализаций — антирекорд
Украина	370	7,4	21,2 суицида/100 тыс.; реформа в условиях войны
Индия	85	1,7	1,18% бюджета Минздрава; разрыв в лечении 70–92%
Нигерия	67	1,3	0,38 врача на 1 000 — только mhGAP
Эфиопия	35	0,7	нижний край выборки
Пакистан	30	0,6	60 центов на психическое здоровье в год (модельно)

1,18% бюджета — и 38% освоения

₹1 180 крор (≈\$140 млн) на 1,44 млрд жителей — **около 10 центов на человека в год**. В 2022 году 94% бюджета ушло на два федеральных института.

Районная программа DMHP покрывает 767 округов, но за 2015–2021 освоила только **38% средств**: «бюджет выделен» ≠/ «помощь оказана». Ответ — NIMHANS 2.0 в бюджете 2026-27.



Деньги вслед за человеком

Закон 10.216 (2001): койки 51 393 → 25 988 (–58%), доля федеральных средств на общинную помощь 24,8% → **79,4%**, сеть CAPS 0,21 → 0,90 на 100 тыс.

Пособие «Volta para Casa» — **R\$709,25/мес (≈\$140)** бывшим пациентам длительных госпитализаций: дешевле койки и гуманнее.



46,7%

повторных госпитализаций — «вращающаяся дверь»

7 846 коек (4,2/10 тыс.), ALOS 51,4 дня. Почти каждая вторая госпитализация — возврат: система лечит обострения, но не удерживает ремиссию. Готовый KPI для любой системы: снижение доли возвратов — самый дешёвый способ высвободить койки.

| Общее наследие — разные траектории

- **Украина:** 21,2 суицида/100 тыс. — второе значение выборки; \$370 на здравоохранение при 8,2% ВВП; постсоветская сеть + реформа общинной помощи, прерванная войной.
- **Беларусь:** \$558/чел., 15,6 суицида — стационарная модель без публичной реформы.
- **Грузия и Армения:** \$554 и \$767 на человека; суициды 5,1 и 2,5 — низкие значения кавказской статистики (с оговоркой о регистрации).
- **Россия** — отдельно: части VI–VII.

| Когда \$0,04 — это весь бюджет

€311 — год пациента в Танзании

Нигерия: \$67 на здравоохранение, 0,38 врача на 1 000. Эфиопия: \$35. Пакистан: \$30. Бангладеш: \$53. При такой базе специализированная сеть невозможна в принципе — единственная рабочая стратегия ВОЗ — **mhGAP**: обучить врачей общей практики базовым протоколам.

Даже самая бедная система может делать осмысленные вещи, если тратит свои €311 на правильный уровень помощи.

147 больниц, 122 537 коек, 12 297 психиатров



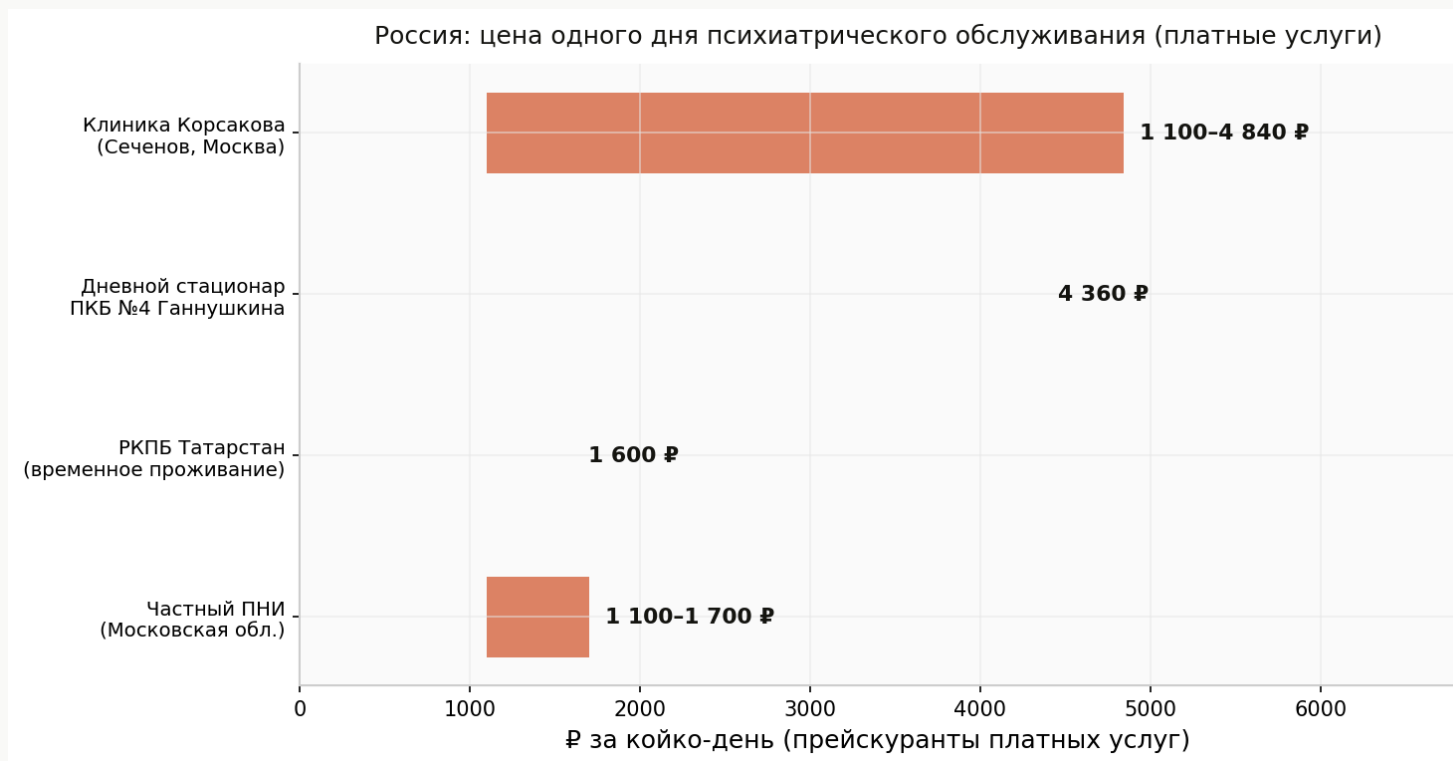
Сколько стоит психиатрия для бюджета России

Расходы на здравоохранение РФ: **\$1 003/чел. (7,0% ВВП, 2023)** $\approx$ 85 500 Р. Мировая медиана 2% на психическое здоровье — это **$\approx$ \$20, или $\approx$ 1 700 Р на человека в год** (модельная оценка).

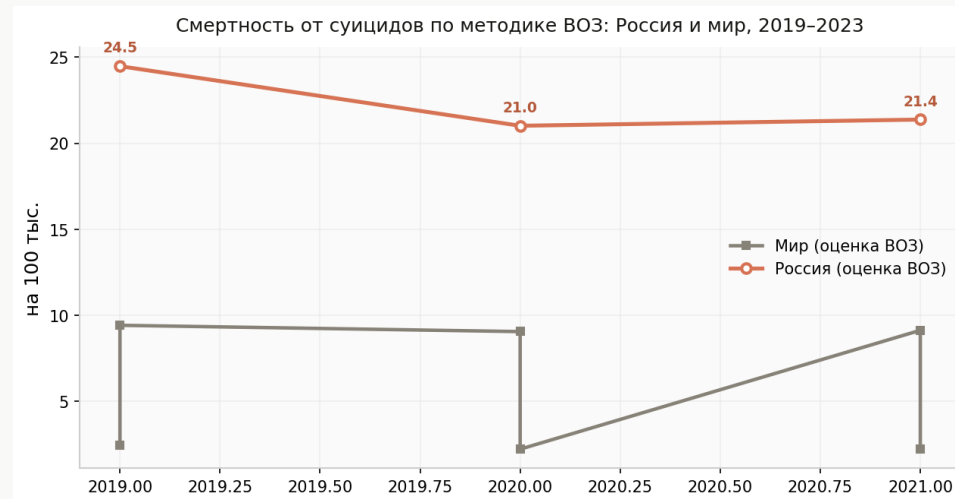
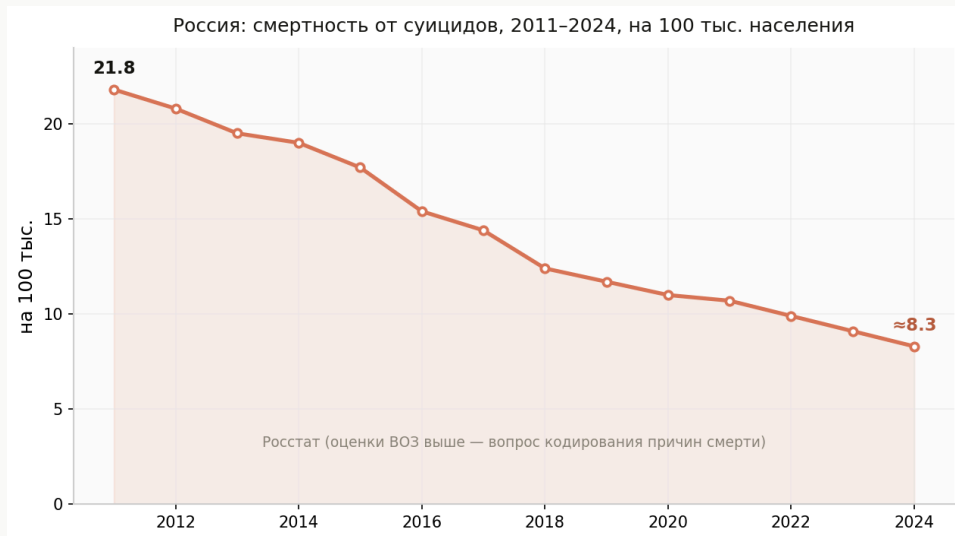
Каждые +0,5 п.п. сверх медианы = +430 Р/чел. = **+63 млрд Р на страну**.

Отдельной строки «психиатрия» в бюджете нет — в отличие от британского KPI. Свести такую цифру на уровне региона под силам каждому участнику семинара.

Койко-день: 1 100 – 4 840 ₽



Суицид в России: 21,8 → 8,3



Росстат: 9,1 (2023) → ≈8,3 (2024). Оценка ВОЗ выше (21,4 за 2021) — другая методика учёта, но тренд тот же: вдвое выше мировой медианы, но уверенно вниз. Мужчины умирают в 5,6 раза чаще женщин.

Реформа коечного фонда: 118 → 62 на 100 тыс.

118,1 → 62 коек на 100 тыс. (2013 → 2016)

Планы оптимизации — порядка 12,5 при рекомендуемых ~140 на 100 тыс. для полного контура. Удар пришёлся на длительные койки — их функция фактически перенесена в ПНИ.

Цена московского дня: 4 360 ₽ дневной стационар ПКБ №4 им. Ганнушкина; частные ПНИ Подмосковья — 1 100–1 700 ₽/сутки (33 000–51 000 ₽/мес).

Двенадцатикратная Россия

Группа регионов	Суициды на 100 тыс.
Москва (минимум)	3,8
Россия (2023)	9,1
Сельские мужчины (по стране)	32,5
Алтай, Тыва, Бурятия, Ненецкий и Чукотский АО	48+

Различия коррелируют с качеством выявления депрессии на первичном звене сильнее, чем с числом коек. Ранняя помощь дешевле поздней — в рублях и в жизнях.

Пять стран — 33-кратная вилка

Страна	€ в год	Что входит в счёт
Германия	10 493	лечение + реабилитация + жильё + пенсия
Израиль	6 955	лечение + легализованная реабилитация
Уганда	1 288	лечение и базовая поддержка
Индия	1 013	лечение; семья несёт уход
Танзания	311	минимальный контур

Российская точка (год стационара по 1 600 Р/день) ≈ \$6 850 — между Израилем и Германией по цене. Вопрос — что человек получает за эти деньги.

Четыре вывода, которые держатся на 48 странах

- **Деньги задают потолок, но не результат:** Корея (\$3 044) — 27,5 суицида; Греция (\$1 963) — 4,7.
- **Структура важнее суммы:** одни и те же деньги покупают США (0,35 коек/1 000) и Японию (2,58).
- **Общинная помощь — не экономия, а перенос:** Бразилия, Италия и UK переместили расходы из больниц в общину.
- **Самая дорогая ошибка — поздняя помощь:** 1:4 (Chisholm), очередь 1,8 млн (NHS), 46,7% возвратов (Казахстан).

Шесть измеримых признаков

- Доля бюджета на психическое здоровье $\geq 2\%$ — и публикуется
- Недобровольные госпитализации посчитаны по методике ВОЗ
- Госпитализации длиннее года $\rightarrow$ к нулю (мир: $>20\%$)
- Доля повторных госпитализаций снижается (антирекорд: $46,7\%$)
- Есть денежный инструмент деинституционализации (модель Бразилии)
- Суицидальная смертность публикуется по регионам

Девять чисел, которые стоит знать о своём регионе

- Койки на 100 тыс. (ОЭСР 64 · РФ 84 · Москва 62)
- Психиатры на 100 тыс. (мир 8,6 · РФ 8,4)
- Доля госпитализаций > года (мир >20%)
- Повторные госпитализации (антирекорд 46,7%)
- ALOS, дни (Казахстан 51 · Япония 266)
- Цена койко-дня, ₽ (вилка РФ 1 100—4 840)
- Суициды на 100 тыс. (3,8 — 48+)
- Доля бюджета на псих. здоровье (мир 2% · NHS 8,4—9,0%)
- Места сопровождаемого проживания на 100 тыс.

Заполнив девятку, регион получает позицию в мировых рейтингах, аргументы для бюджета и повестку реформы.

Что предлагается обсудить

- **Прозрачность:** свести и опубликовать долю психического здоровья в бюджете региона — по образцу британского KPI
- **Деньги вслед за человеком:** пособие, сертификат или соцзаказ — что способно заменить койко-место?
- **Вращающаяся дверь:** считает ли ваше учреждение долю повторных госпитализаций?
- **Цена дня:** что система покупает за 1 600–4 800 ₽ — и что могла бы купить вместо этого в амбулаторном звене?

Три вопроса на проверку внимания

- Мировая медиана расходов на психическое здоровье на человека в год?
а) \$2,69 · б) \$26,9 · в) \$269 · г) \$0,27
- Сколько психиатрических коек в России (2023)?
а) 25 988 · б) 51 393 · в) 122 537 · г) 147 000
- Какая страна закрыла психиатрические больницы ещё в 1978 году?
а) Бразилия · б) Италия · в) Великобритания · г) Франция

Полный квиз — 15 вопросов в разделе 9.3 доклада, готов к загрузке в интерактивную платформу.



ЦЕНА ЗАБОТЫ · 2026

Спасибо за внимание

Доклад: 150 страниц, 48 стран, 20 графиков, 60+ таблиц.

Материалы семинара — на странице проекта. Вопросы и обсуждение — в секциях.
